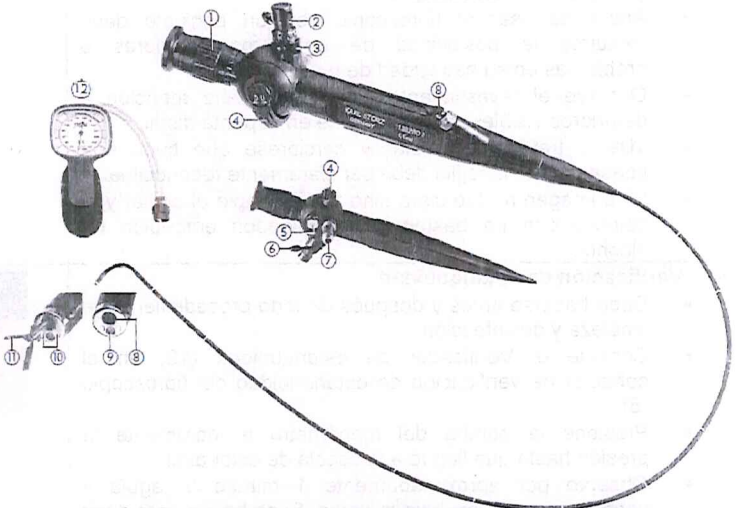
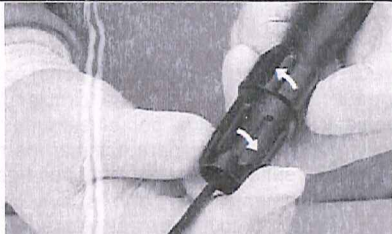
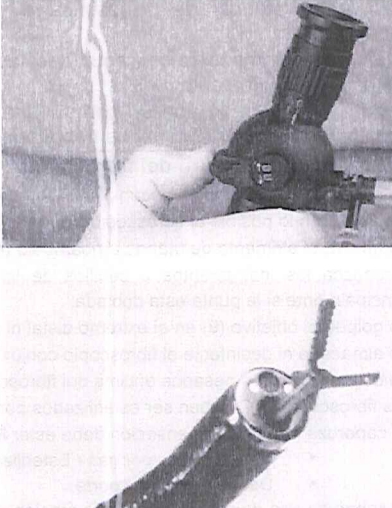
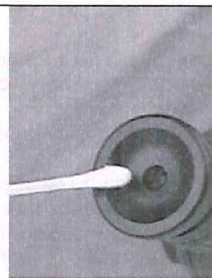


 BIOTRONITECH Colombia	GUÍA DE MANEJO: FIBROSCOPIO_KAR STORZ_110XX-113XX AREA TECNICA	Vigencia: A partir del 01-01-2013 Versión: 1.0 Pág. 1 de 2
• Composición del Fibroscopio 1. Anillo de enfoque 2. Suplemento/válvula de succión (si existe) a. Presionar: Función de succión activada b. Soltar: Función de succión desactivada 3. Conector de válvula (Si existiese) 4. Elemento de mando subir/bajar 5. Válvula para compensación de presión y para conexión del verificador de estanqueidad 6. Conexión de succión 7. Conector de fuente de luz 8. Canal para instrumentos 9. Objetivo 10. Salida de luz 11. Instrumento en el canal para instrumentos 12. Verificador de estanqueidad		
• Montaje de la válvula de succión Coloque el suplemento para la válvula de succión (2) sobre el conector de la válvula (3) y gire hasta que los botones laterales del suplemento descansen sobre los recortes del manguito. Encastre el suplemento de la válvula de succión, presionando ligeramente en los conectores de la válvula.		
• Montaje del soporte del tubo (solamente para fibroscopio de intubación) EL soporte del tubo hay que deslizarlo sobre el fibroscopio a partir de la punta distal, fijándolo mediante giro de ambas piezas en dirección opuesta.		
• Introducir el Fibroscopio • Al introducir el fibroscopio en el paciente, la punta distal del mismo ha de estar en posición recta, no acodada. • Si no se ha introducido ningún instrumento, cierre el extremo proximal del canal para instrumentos con el tapón correspondiente. • Si ha de introducirse un instrumento, coloque la válvula de labios desechable a fin de hermetizar el canal. • Las pinzas, tijeras y otros accesorios con mordazas que puedan abrirse y cerrarse. Deben introducirse siempre con las mordazas cerradas en el canal para los instrumentos. Las mordazas solo podrán abrirse cuando la punta distal del instrumento sobresalga completamente fuera del canal. • En caso de que en el canal de trabajo se encuentre instrumental, puede estar limitada la deflexión debido a la rigidez adicional de los instrumentos.		

 BIOTRONITECH Colombia	GUÍA DE MANEJO: FIBROSCOPIO_KAR STORZ_110XX-113XX	Vigencia: A partir del 01-01-2013
		Versión: 1.0
	AREA TECNICA	Pág. 2 de 2

• Preparación del fibroscopio

- Antes de usar el fibroscopio con un paciente debe excluirse la posibilidad de deterioros exteriores o problemas en su capacidad de funcionamiento.
- Observe el revestimiento exterior y preste atención a deterioros visibles, especialmente en la punta distal.
- Mire a través del ocular y cerciórese que tiene una imagen clara, la rejilla debe ser claramente reconocible.
- Si la imagen no fue clara sino turbia, limpie el ocular y el objetivo con un bastoncillo de algodón embebido en alcohol.



• Verificación de estanqueidad

- Debe hacerse antes y después de todo procedimiento de limpieza y desinfección.
- Conecte el Verificador de estanqueidad (12) en el conector de verificación de estanqueidad del fibroscopio (5)
- Presione la bomba del manómetro e incremente la presión hasta que llegue a la escala de color azul.
- Observe por aproximadamente 1 minuto la aguja y verifique que no se baje la aguja. Si se baja quiere decir que baja la presión interna y por tanto que el fibroscopio tiene fuga y debe ser enviado al departamento técnico.



• Limpieza y desinfección:

- Deslice un paño suave humedecido con agua o desinfectante y páselo por el cuerpo del fibroscopio para retirar los restos de sangre o secreciones.
- Desconecte todos los accesorios y conectores del fibroscopio
- Realice pruebas de estanqueidad
- Introduzca el fibroscopio en un tanque amplio con desinfectante.
- Inyecte o succione desinfectante por el canal de trabajo.
- Introduzca el cepillo de forma circular por el canal de trabajo y cuando salga por el extremo distal, limpie el cepillo con otro cepillo para eliminar los residuos. Saque el cepillo y repita el paso por lo menos tres veces.
- Pase nuevamente un paño suave humedecido con desinfectante por lo menos tres veces
- Desinfecte todos los accesorios y conectores por separado.
- Enjuague el fibroscopio con agua destilada para eliminar restos del desinfectante.
- Seque el fibroscopio con un paño suave seco e inyecte aire comprimido por el canal de trabajo (máximo 0,5 bar).



• Cuidado y manejo seguro del fibroscopio

- En ningún caso doble el fibroscopio ni lo enrolle de forma demasiado apretada.
- Almacene en lo posible el fibroscopio colgándolo o depositándolo en recipientes amplios
- No mueva el elemento de mando arriba/abajo (4) de forma brusca o violenta.
- Introduzca los instrumentos o cepillos de limpieza en los canales sin emplear violencia, esto puede provocar deterioros internos, principalmente si la punta esta doblada.
- No golpee el objetivo (9) en el extremo distal ni lo limpie usando objetos afilados
- No almacene ni desinfecte el fibroscopio conjuntamente con otros objetos afilados.
- No deposite objetos pesados encima del fibroscopio.
- Los fibroscopios NO deben ser esterilizados por Vapor, Autoclave ni Ultrasonido.
- La caperuza roja de compensación debe estar **MONTADA** en los pitones de aireación para cada:
 - Esterilización por gas / Esterilización por plasma.
 - Despacho o transporte.
- La caperuza roja de compensación de presión debe **RETIRARSE** de los pitones de aireación antes de cada:
 - Intervención endoscópica.
 - Inmersión en líquidos/ Esterilización química.

- Este documento no reemplaza el manual de usuario, cualquier duda debe referirse a dicho manual.